République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis — Mostaganem
Faculté de Médecine

Service de Rhumatologie — CHU Mostaganem

Polyarthrite Rhumatoïde

Cours orienté QCM — Préparation Examen OTR

Source principale : Dr Youcef A., Service de Rhumatologie, CHU Mostaganem
Corpus QCM : Banque QCM OTR (questions 612–650, 1305–1306 et connexes)
Objectif : Lire une fois → répondre correctement à tous les QCM de la PR

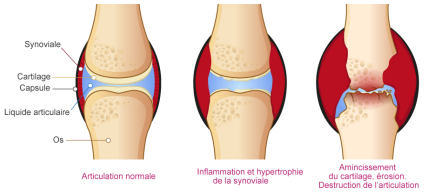
Table des matières

1. Définition & Épidémiologie
2. Physiopathologie
3. Diagnostic positif — PR débutante
4. PR à la phase d'état
5. Diagnostic différentiel
6. Évolution, pronostic & comorbidités
7. Évaluation — DAS28
8. Traitement
9. Suivi
10. Tableaux de synthèse — « Ce qui tombe en QCM »
11. Points clés à retenir absolument

1. Définition & Épidémiologie

Définition

La polyarthrite rhumatoïde est une **maladie inflammatoire auto-immune et systémique** à prédominance **synoviale**, d'étiologie inconnue mais impliquant plusieurs facteurs. C'est un **rhumatisme inflammatoire chronique (RIC) destructeur, déformant et invalidant** — d'où l'intérêt d'un **diagnostic précoce** +++ et d'un traitement efficace.



Épidémiologie

- **Le RIC le plus fréquent**.
- Prévalence : **0,3–1 %**. Incidence : **25–50 / 100 000**.
- **Prédominance féminine : 3 à 4 femmes / 1 homme**, différence qui s'atténue après 60 ans.
- **Pic de fréquence : 40–60 ans**, mais peut survenir à tout âge.

> 🔴 **QCM 617 / 638 — Pièges classiques**
> - « PR plus fréquente chez l'homme jeune » → **FAUX**.
> - « PR d'étiopathogénie infectieuse » → **FAUX**.
> - « PR = rhumatisme dégénératif » → **FAUX** (elle est **inflammatoire**).

2. Physiopathologie

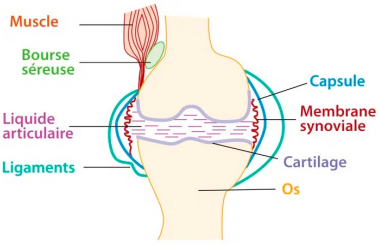
Facteurs impliqués

Facteur	Détails
Génétique	HLA-DR (reconnaissance antigénique)
Environnementaux	Tabac, microbiote buccal et intestinal → **citrullination excessive** des protéines
Hormonaux	Rémission fréquente pendant la grossesse ; hypoandrogénie chez l'homme
Psychologiques	Choc affectif possible

Cascade physiopathologique

Rupture de tolérance au niveau des muqueuses (poumon, bouche, intestin) → production d'auto-anticorps (**FR** et **ACPA**) → réponse **systémique** → **synovite** articulaire → **destruction articulaire** (érosions osseuses + pincement de l'interligne = chondrolyse).

Cellules clés : lymphocytes T et B, macrophages, fibroblastes, ostéoclastes. **Cytokines clés : TNFα, IL-6** → cibles thérapeutiques.



> 🔴 **QCM 650 — Lésion élémentaire de la PR**
> - « La synovite est la lésion élémentaire » → **VRAI**.
> - « L'enthésite est la lésion élémentaire » → **FAUX** (c'est la SpA).

3. Diagnostic positif — PR débutante

> **Définition de la PR débutante**
> Durée d'évolution **< 6 mois** (voire 12 mois). Diagnostic le plus précoce possible, surtout les **3 premiers mois** → **fenêtre d'opportunité** pour la rémission.

3.1 Clinique

Mode de début le plus fréquent (70–80 %) :

- **Oligoarthrite ou polyarthrite distale, BILATÉRALE et globalement SYMÉTRIQUE**
- **Fixe et additive**, d'apparition **progressive**
- Évolution ≥ **6 semaines**
- Habituellement **sans signes extra-articulaires**
- Atteinte : **poignets, MCP (2e–3e), IPP, MTP, chevilles**, parfois genoux et coudes
- **Les IPD sont respectées**
- **Ténosynovites** fréquentes (extenseurs des doigts, ulnaire du carpe, fléchisseurs, fibulaires, tibial antérieur/postérieur)

Signes fonctionnels : douleur articulaire d'**horaire inflammatoire** ; signes généraux discrets possibles.

Signes physiques :

- **Gonflement articulaire** (synovite ± épanchement) → limitation de mobilité
- **Doigts en fuseau** (évocateur ++)
- **Squeeze test** douloureux (compression latérale MCP / MTP)

Autres modes de début (rares) : polyarthrite aiguë fébrile ; monoarthrite ; **forme rhizomélique** (hanches + épaules, sujet > 65 ans) ; **forme palindromique** (poussées mono/oligoarticulaires récidivantes, régressives en 2–3

Ce texte décrit la physiopathologie de la Polyarthrite Rhumatoïde (PR). Pour retenir cette cascade facilement (surtout pour tes révisions de résidanat), il faut la voir comme une guerre chronologique où le système immunitaire se trompe d'ennemi.

Voici l'explication étape par étape, de façon claire et logique :

1. L'élément déclencheur : La rupture de tolérance (L'erreur de cible)

- Où ça se passe ? Dans les muqueuses (poumons, bouche, intestins).
- Que se passe-t-il ? À cause de facteurs environnementaux (ex: le tabac pour les poumons, une parodontite pour la bouche), certaines protéines de ton corps sont modifiées (elles subissent une *citrullination*). Ton système immunitaire ne les reconnaît plus comme amies (rupture de tolérance) et décide de les attaquer.

2. La préparation de l'armée : Auto-anticorps et Réponse systémique

- Les armes (Auto-anticorps) : Les lymphocytes B se mettent à fabriquer des anticorps contre ces protéines modifiées. Ce sont les fameux ACPA (très spécifiques à la PR) et le Facteur Rhumatoïde (FR).
- L'invasion (Réponse systémique) : Ces anticorps circulent dans tout le sang. C'est pour cela que la PR est une maladie *systémique* (qui donne de la fatigue, une inflammation générale, etc., avant même que les articulations ne soient détruites).

3. Le champ de bataille : La Synovite articulaire

- La cible : Les auto-anticorps se déposent dans les articulations, spécifiquement sur la membrane synoviale (le tissu qui tapisse l'articulation).
- Le résultat : La membrane s'enflamme, s'épaissit et prolifère. C'est ce qu'on appelle le pannus synovial. L'articulation devient rouge, chaude, gonflée et douloureuse.

4. Les dégâts irréversibles : La Destruction

Le pannus synovial agit comme une tumeur locale très agressive qui ronge ce qui l'entoure :

- Le cartilage : Il est détruit (chondrolyse). À la radio, cela se traduit par un pincement de l'interligne articulaire (l'espace entre les deux os diminue).
- L'os : Il est grignoté. À la radio, on voit des érosions osseuses (des "trous" sur les bords de l'os).

5. Le casting (Qui fait quoi ?)

Pour comprendre comment traiter la maladie, il faut connaître les acteurs responsables de cette destruction :

Les Cellules (Les soldats) :

- Lymphocytes T et B : Les généraux qui dirigent l'attaque et produisent les anticorps (ACPA/FR).
- Macrophages et Fibroblasts : Les troupes au sol qui entretiennent l'inflammation et forment le pannus synovial épaissi.
- Ostéoclastes : Les destructeurs. Ils sont suractivés par l'inflammation et "mangent" l'os (créant les érosions).

Les Cytokines (Les messagers chimiques) :

- TNFα et IL-6 : Ce sont les signaux d'alarme qui disent aux cellules de continuer à attaquer et à s'enflammer.
- Cibles thérapeutiques : C'est le point clé pour le résidanat. Puisque le TNFα et l'IL-6 sont les principaux moteurs de l'inflammation, les médicaments modernes (biothérapies) vont venir bloquer ces messagers (ex: *Anti-TNFα* ou *Anti-IL6*) pour stopper complètement cette cascade et sauver l'articulation.

1. Les 5 caractéristiques en or (Le tableau classique)

Quand la maladie commence, elle suit une chorégraphie très précise :

- Distale : Elle attaque les extrémités (mains, poignets, pieds).
- Bilatérale et Symétrique : Si elle touche la main droite, elle touchera la main gauche de la même manière.
- Fixe et Additive : C'est une inflammation qui conquiert un territoire et ne le lâche plus. Les articulations touchées restent malades, et de *nouvelles* articulations viennent s'y ajouter au fil des semaines (contrairement au RAA qui est *migrateur*).
- Inflammatoire : La douleur réveille le patient la nuit et s'accompagne d'une raideur matinale (dérouillage).
- Chronique (> 6 semaines) : C'est le critère de temps indispensable. Si ça dure depuis moins de 6 semaines, on ne peut pas encore affirmer que c'est une PR (ça pourrait être une arthrite virale passagère).

2. La topographie (Où ça fait mal ?)

- Les cibles favorites : Les poignets, les MCP (base des doigts, surtout les 2ème et 3ème), les IPP (milieu des doigts) et les MTP (base des orteils). L'inflammation déborde souvent sur les tendons autour (ténosynovites).
- LE PIÈGE DE QCM ABSOLU : Les IPD (bout des doigts) sont RESPECTÉES.
    - *Astuce:* Si un cas clinique décrit une atteinte des IPD, élimine la PR. Pense plutôt à l'arthrose ou au rhumatisme psoriasique.

3. L'examen clinique (Ce que le médecin trouve)

Si tu examines les mains de ce patient, tu vas chercher 3 choses :

- La synovite : L'articulation n'est pas dure comme de l'os (comme dans l'arthrose), elle est gonflée, chaude et "spongieuse" (élastique) à cause de l'inflammation de la membrane et du liquide.
- Les doigts en fuseau : C'est très évocateur. Comme l'articulation du milieu du doigt (IPP) est très gonflée, le doigt prend la forme d'un fuseau (plus épais au milieu qu'aux extrémités, comme un petit ballon de rugby).
- Le Squeeze Test (ou signe de la poignée de main) : Tu presses latéralement l'ensemble des articulations de la base des doigts (MCP) ou des orteils (MTP) entre ton pouce et ton index. Si le patient grimace de douleur, le test est positif.

4. Les modes de début rares (Les exceptions)

Parfois, la maladie ne lit pas les livres de médecine et commence bizarrement :

- Forme rhizomélique : "Rhizo" = racine. Au lieu de toucher les extrémités, elle attaque les épaules et les hanches. C'est typique chez les sujets âgés (> 65 ans).
- Forme palindromique : C'est une forme qui "joue à cache-cache". Des crises articulaires très brutales qui disparaissent complètement et sans séquelles en 2-3 jours, puis récidivent des semaines plus tard (avant de finir par se transformer en vraie PR permanente).
- Aiguë fébrile ou Monoarthrite : Un début brutal avec de la fièvre, ou une seule articulation touchée (ce qui obligera d'abord à éliminer une infection articulaire).

> 🔴 **QCM 649 — Début évocateur de PR**
> **Atteinte distale bilatérale et symétrique** = bonne réponse.
> **FAUX :** début par rachis lombaire, monoarthrite aiguë fébrile, oligoarthrite asymétrique avec talalgies, bi-arthrite post-diarrhéique.

3.2 Biologie

Syndrome inflammatoire biologique dans 90 % des cas (inconstant) : ↑ **VS** et/ou **CRP**, ↑ **alpha-2**, **anémie inflammatoire**, thrombocytose.

> 🔴 **QCM 614 / 636 — Bilan biologique de la PR**
> CRP positive, ACPA positifs, anémie, Waaler-Rose positif → **TOUTES LES RÉPONSES SONT JUSTES**.

Bilan d'auto-immunité

Marqueur	Sens.	Spéc.	Détails
Facteur rhumatoïde (FR)	60–80 %	65–85 %	**IgM anti-IgG**. (Waaler-Rose, latex). **Positif chez ~75 % à 1 an**. **Non spécifique**. Négativité n'élimine pas.
ACPA (anti-CCP)	60–75 %	**90–95 %**	**Plus spécifiques** que le FR. Apparition précoce. Négativité n'élimine pas.
AAN	—	—	Le plus souvent **négatifs**. À rechercher pour éliminer un **lupus**.

> 🔴 **QCM 646 — Waaler-Rose et QCM 647 — Liquide synovial**
> Waaler-Rose : Moins sensible mais plus spécifique que le latex. Négativité n'exclut pas. (**VRAI**)
> Liquide synovial de PR : **> 2 000 leucocytes/mm³**, **stérile**, **NE CONTIENT PAS de microcristaux**.



3.3 Imagerie

Radiographies standards (systématiques) : Mains/poignets de face, Pieds face/3/4, autres articulations douloureuses, thorax. **Résultats : Le plus souvent NORMALES au début**. Parfois tuméfaction, **déminéralisation épiphysaire en bandes**, **érosions osseuses marginales précoces** (tête du **5e métatarsien**). **Écho/IRM :** Plus sensibles pour détecter synovite/érosions précoces.

3.4 Critères ACR / EULAR 2010 (PR débutante)

Domaine	Critère	Points
Atteinte articulaire (0–5)	1 grosse art. (0) / 2–10 grosses art. (1)	0 – 1
	1–3 petites articulations	2
	4–10 petites articulations	3
	> 10 articulations (au moins 1 petite)	5
Sérologie (0–3)	FR négatif ET ACPA négatif (0) / faiblement positifs (2)	0 – 2
	FR fortement positif (> 3 N) OU ACPA fortement positif (> 3 N)	3
Symptômes (0–1)	< 6 semaines (0) / ≥ 6 semaines (1)	0 – 1
Biologie infl. (0–1)	CRP et VS normales (0) / CRP ou VS anormale (1)	0 – 1

Score ≥ 6 → Polyarthrite Rhumatoïde.

4. PR à la phase d'état

4.1 Manifestations ostéo-articulaires

Les gonflements évoluent vers des **déformations irréversibles**. Toutes les articulations périphériques + **rachis cervical** peuvent être touchés. **Le rachis thoracolombaire, les sacro-iliaques et les IPD sont respectés.**

Atteinte des mains (la plus fréquente et précoce) — Déformations

Déformation	Description
Déviation ulnaire « coup de vent »	Déviation des doigts vers le cubitus
Col de cygne	**Flexion MCP + hyperextension IPP + flexion IPD**
Boutonnière	**Flexion IPP + hyperextension IPD**
Maillet / marteau	**Flexion IPD**
Pouce en « Z »	Arthrite MCP du pouce
Pouce adductus	Arthrite trapézo-métacarpienne
Touche de piano	Luxation de la styloïde ulnaire (arthrite radio-ulnaire distale)
Dos de chameau	Déformation carpienne (QCM 612)
Arthrite radiocarpienne	Subluxation ventrale du carpe
Arthrite médio-carpienne	Carpite fusionnante

> 🔴 **QCM 612 / 613 / 634 / 635 — Déformations PR**
> **VRAI :** touche de piano, déviation cubitale, dos de chameau, col de cygne, pouce en Z, doigt en maillet.
> **FAUX :** main de Jaccoud (lupus), nodosités d'Heberden (arthrose IPD), durillons plantaires.

Atteinte des pieds

- **Avant-pied triangulaire :** hallux valgus + **coup de vent fibulaire** des orteils + **quintus varus**.
- **Médio-pied / arrière-pied : pied plat valgus**.

4.2 Manifestations extra-articulaires

Traduisent le **caractère systémique** ; peuvent menacer le pronostic vital.

Domaine	Atteintes
Signes généraux	Fièvre, asthénie, adénopathies superficielles, **syndrome sec**
Nodules rhumatoïdes	Sous-cutanés, pleuropulmonaires…
Pleuropulmonaires	**Pneumopathies interstitielles diffuses (PID)**, pleurésies
Cardiovasculaires	Péricardites, myocardites
Cutanés	**Vascularite rhumatoïde**
Ophtalmologiques	**Sclérite, épisclérite, scléromalacie perforante**
Hématologiques	**Syndrome de Felty**, leucémie à grands lymphocytes granuleux

> 🔴 **QCM 618 / 645 — Atteintes extra-articulaires**
> **VRAI :** épanchements synoviaux multiples, compression médullaire, syndrome de Raynaud, vascularite.
> **NON retrouvé : Uvéite antérieure aiguë** (SpA), **Sacro-iléite bilatérale** (SpA).

4.3 Biologie & imagerie à la phase d'état

Biologie : syndrome inflammatoire, FR++, ACPA++. Liquide articulaire inflammatoire, stérile, sans cristaux.

Radiographies : mains, poignets, pieds, **rachis cervical** (clichés dynamiques pour recherche de luxation atloïdo-axoïdienne). **Résultats : érosions périarticulaires**, **géodes intraosseuses juxta-articulaires**, **pincement de l'interligne**, **désaxations**, **déminéralisation en bandes**.



> 🔴 **QCM 641 — Signes radiographiques**
> **VRAI :** érosions, géodes sous-chondrales, pincement global, déminéralisation en bande.
> **FAUX :** épaississement des corticales.

5. Diagnostic différentiel

- **Infectieuses ; Spondyloarthrites (SpA)**
- **Connectivites :** Gougerot-Sjögren, lupus systémique, sclérodermie
- **Métaboliques :** goutte, chondrocalcinose (rhumatisme à PPC)
- **Arthrose**

6. Évolution, pronostic & comorbidités

Évolution

Sans traitement : aggravation, **handicap fonctionnel important après 10 ans (50% des patients)**. **Surmortalité cardiovasculaire (1re cause)**, infections, cancers.

> 🔴 **QCM 644 — PR, pronostic**
> **VRAI :** parfois mortelle du fait d'une atteinte cardiaque ; conduit généralement à une infirmité importante ; peut se compliquer d'amylose.
> **FAUX :** « généralement mortelle par manifestations viscérales tardives constantes ».

Facteurs de mauvais pronostic

- **DAS28 > 3,2 persistant** ; **Syndrome inflammatoire marqué**
- **FR et/ou ACPA positifs forts (> 3 N)** ; **Érosions radiographiques**
- **HAQ > 0,5** ; Manifestations extra-articulaires ; Comorbidités.

Comorbidités

Comorbidité	Détails
Cardiovasculaires	IDM, AVC
Cancers	Surrisque de **lymphome** (activité sévère) et **cancer pulmonaire**
Infections	Liées à la maladie + **iatrogènes** (corticoïdes, biothérapies)
Osseuses	**Ostéoporose** (inflammation + iatrogène)

> 🔴 **QCM 624 / 630 — Facteurs de risque d'ostéoporose**
> **VRAI :** corticothérapie au long cours, PR, héparine prolongée.
> **FAUX :** contraceptifs oraux, ménopause à 50 ans (âge normal).

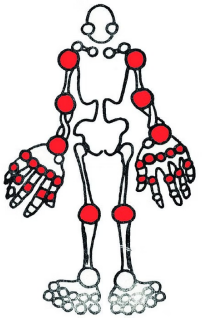
7. Évaluation — DAS28

DAS28 = score validé d'activité. Évalue **28 articulations** : **2 épaules, 2 coudes, 2 poignets, 10 MCP, 10 IPP, 2 genoux**. *(Les pieds ne sont pas comptés dans le DAS28).*

Paramètres : articulations douloureuses, gonflées, EVA patient, **VS ou CRP**.

Activité	DAS28	Activité	DAS28
Rémission	**< 2,6**	**Activité modérée**	3,2 – 5,1
Faible activité	2,6 – 3,2	**Activité élevée**	**> 5,1**

8. Traitement



Objectif : **Rémission** ou faible niveau d'activité (Treat to Target).

8.1 Symptomatique et de fond conventionnel

- **Corticothérapie :** Appoint (**Prednisone ~10 mg/j**), sevrage visé à 3–6 mois.
- **AINS & Antalgiques :** Dose minimale efficace, temps court.

Molécule	Posologie	Remarques
Méthotrexate (MTX)	**0,3 mg/kg/sem**	**1re ligne absolue**. Voie PO ou SC. + **Folates** ≥ 5 mg/sem. Contraception !
Léflunomide	20 mg/j	Alternative au MTX si CI
Sulfasalazine	1 à 3 g/j	Alternative au MTX si CI

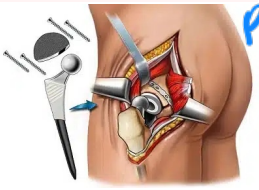
8.2 Thérapies ciblées (bDMARD et tsDMARD)



Biologiques : **anti-TNFα, anti-IL-6R, CTLA4-Ig, anti-CD20**. Synthétiques : **JAKi**.

> 🔴 **QCM 1306 — Traitement de fond de la PR**
> **VRAI :** Anti-TNFα, Méthotrexate, Léflunomide.
> **FAUX :** Méthylprednisolone (corticoïde, = sympto), Diclofénac (AINS).

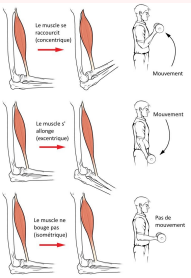
8.3 Non pharmacologique et chirurgie



- Éducation, rééducation, **orthèses de repos / position de fonction**, soutien psy.
- Chirurgie : arthroplasties (prothèses), synovectomies (rare).

> 🔴 **QCM 628 — PR en poussée**
> **VRAI :** repos articulaire, orthèse en position de fonction, travail musculaire isométrique. (**FAUX :** balnéo, orthèse dynamique).

8.4 Stratégie (Algorithme)



1. **MTX + corticoïdes**.
2. Si échec à 3–6 mois + facteurs mauvais pronostic → **Thérapie ciblée**.
3. Si échec sans facteurs de mauvais pronostic → Autre fond conventionnel.

9. Suivi

Clinique/biologique **tous les 1–3 mois** jusqu'à l'objectif, puis tous les 3–6 mois. Radio : tous les 6 mois la 1re année, puis /an (3 ans)

10. Tableaux de synthèse — « Ce qui tombe en QCM »

🔴 Pièges classiques (Vrai / Faux)

Affirmation	V / F	Précision
PR plus fréquente chez l'homme jeune	**FAUX**	Prédominance féminine 3–4 F/1 H, pic 40–60 ans
PR = rhumatisme dégénératif	**FAUX**	Rhumatisme **inflammatoire** chronique
PR d'étiopathogénie infectieuse	**FAUX**	Auto-immune, facteurs génétiques + environnementaux
La PR ne s'observe jamais chez le sujet âgé	**FAUX**	Peut survenir à tout âge (forme rhizomélique > 65 ans)
Les AAN sont les principaux marqueurs	**FAUX**	**FR et ACPA** sont les principaux
Les signes extra-articulaires = mode de début fréquent	**FAUX**	Mode de début rare ; début = polyarthrite distale
Les radiographies sont toujours anormales au début	**FAUX**	**Souvent normales** au début
La sérologie rhumatoïde est toujours positive	**FAUX**	Négativité n'élimine pas le diagnostic
La PR épargne les sacro-iliaques et les IPD	**VRAI**	Atteinte possible mais **habituellement respectées**
La PR touche le rachis thoracolombaire	**FAUX**	**Rachis cervical** touché ; thoracolombaire respecté

🔴 Déformations : lesquelles sont de la PR ?

Déformation	PR ?	Remarque
Col de cygne	**OUI**	Flexion MCP + hyperextension IPP + flexion IPD
Boutonnière	**OUI**	Flexion IPP + hyperextension IPD
Maillet	**OUI**	Flexion IPD
Pouce en Z	**OUI**	Arthrite MCP du pouce
Déviation cubitale « coup de vent »	**OUI**	Très classique
Touche de piano	**OUI**	Luxation styloïde ulnaire
Dos de chameau	**OUI**	Atteinte du carpe
Main de Jaccoud	**NON**	C'est le Lupus érythémateux systémique
Nodosités d'Heberden	**NON**	C'est l'Arthrose (au niveau des IPD)
Durillons plantaires	**NON**	Trouble statique non spécifique

🔴 Manifestations extra-articulaires : PR ou pas ?

Manifestation	PR ?	Remarque
Nodules rhumatoïdes, Syndrome sec	**OUI**	Spécifiques ou secondaires (Gougerot)
Pleurésie, PID, Péricardite	**OUI**	Atteintes séreuses et interstitielles
Sclérite / épisclérite	**OUI**	Atteinte oculaire
Vascularite, Amylose, Sd de Felty	**OUI**	Complications systémiques
Uvéite antérieure aiguë	**NON**	Typique de la **Spondyloarthrite**
Sacro-iléite bilatérale	**NON**	SpA

🔴 Traitement : les incontournables

Situation	Traitement
1re ligne de fond	**Méthotrexate** (0,3 mg/kg/sem, max 25–30 mg) + folates
Si CI au MTX	Léflunomide ou Sulfasalazine
Corticoïdes	Prednisone ~10 mg/j, sevrage sur 3–6 mois
Échec 1er fond + mauvais pronostic	**Thérapie ciblée :** anti-TNFα, anti-IL-6R, CTLA4-Ig, JAKi
PR en poussée	Repos, orthèse de position de fonction, isométrique
Objectif thérapeutique	**Rémission** (DAS28 < 2,6) ou faible activité

11. Points clés à retenir absolument

1. **PR = RIC le plus fréquent**, femme 3–4/1, pic 40–60 ans.
2. **Début typique :** polyarthrite / oligoarthrite **distale, bilatérale, symétrique**, ≥ 6 semaines, **poignets + MCP 2–3 + IPP + MTP**, **IPD respectées**.
3. **FR = IgM anti-IgG** ; **ACPA plus spécifiques** ; **négativité n'élimine pas** le diagnostic.
4. **Liquide synovial : inflammatoire > 2 000** leucocytes, **stérile**, **sans microcristaux**.
5. **Radios souvent normales au début** ; recherche d'érosions précoces (tête 5e métatarsien évocatrice).
6. **Déformations :** col de cygne, boutonnière, maillet, pouce en Z, déviation cubitale, touche de piano, dos de chameau.
7. **Extra-articulaire :** nodules, PID, péricardite, sclérite, vascularite. **PAS d'uvéite antérieure aiguë** (SpA).
8. **DAS28 :** 28 articulations (ne compte pas les pieds). **Rémission < 2,6**.
9. **Traitement : MTX 1re ligne** + corticoïdes d'appoint. **Anti-TNFα, IL-6R, JAKi** si échec.
10. **Pronostic : surmortalité CV (1re cause)**, infections, cancers, ostéoporose.

Document optimisé pour la révision QCM — Fin du document.